

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos de personalidad (TP)** son entidades **crónicas y complejas**, caracterizadas por **patrones desadaptativos de pensamiento, emoción y conducta** que generan conflictos interpersonales y sufrimiento significativo.

En el contexto chileno, muchos pacientes con TP **acuden primero a centros de APS**, generalmente por síntomas de ansiedad, depresión, somatización o conflictos familiares, sin conciencia del problema subyacente de personalidad.

El **rol del médico de familia o generalista** es crucial para:

- Detectar la presencia de **rasgos de personalidad desadaptativos**.
- **Contener y orientar** al paciente, evitando juicios o confrontaciones.
- Determinar la **necesidad y urgencia de derivación** al nivel especializado (COSAM o psiquiatría).
- Coordinar la atención con equipos multidisciplinarios (psicólogo, trabajador social, enfermería).

□ En el **EUNACOM**, este tema se evalúa mediante casos clínicos donde el paciente presenta comportamientos “difíciles” (por ejemplo, demandas intensas, manipulación, o reacciones desproporcionadas), y se espera que el médico aplique **manejo comunicacional adecuado y derivación oportuna**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Los TP no se consideran enfermedades agudas, sino **trastornos del desarrollo de la personalidad**, que surgen de una combinación de **factores biológicos, psicológicos y sociales**:

- **Biológicos:** alteraciones en la regulación serotoninérgica y dopaminérgica, que afectan el control de impulsos y la modulación emocional.
- **Psicológicos:** patrones de apego inseguros, mecanismos de defensa inmaduros y esquemas cognitivos disfuncionales (“nadie me quiere”, “debo ser perfecto”).

- **Sociales:** trauma infantil, negligencia, abuso o entornos inestables.

Desde el punto de vista del manejo clínico, estos factores explican por qué:

- Los TP son **crónicos y resistentes a cambios rápidos**.
 - El abordaje requiere **paciencia, consistencia y límites claros**.
 - Los episodios de crisis deben diferenciarse de **trastornos afectivos o psicóticos transitorios**.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Motivos de consulta frecuentes en APS

Los pacientes con TP raramente consultan por “problemas de personalidad”.

En cambio, suelen presentarse con:

- **Síntomas ansiosos o depresivos** (“me siento vacía”, “no puedo controlar mis nervios”).
 - **Conflictos interpersonales repetitivos** (rupturas, discusiones laborales, demandas familiares).
 - **Quejas somáticas** persistentes.
 - **Conductas impulsivas o autolesivas leves**.
 - **Quejas contra el sistema de salud o el equipo tratante** (consultante “difícil”).
-

3.2. Claves para sospechar un Trastorno de Personalidad

1. **Patrón estable y repetitivo** de problemas interpersonales.
2. **Reacciones emocionales desproporcionadas** ante el estrés.
3. **Poca autocrítica o externalización de la culpa**.
4. **Inflexibilidad conductual** frente a distintas situaciones.

5. Inicio temprano (adolescencia o adultez temprana).

□ El diagnóstico formal **no se realiza en una sola consulta**, sino tras observación longitudinal y colaboración con el equipo de salud mental.

3.3. Diagnóstico diferencial en APS

Situación	Claves distintivas
Trastorno depresivo o ansioso	Curso episódico, con respuesta a fármacos.
Trastorno adaptativo	Relacionado con un evento vital reciente; se resuelve en semanas.
Trastorno de personalidad	Patrón persistente desde la adolescencia, con impacto funcional.
Trastorno psicótico	Pérdida del juicio de realidad, alucinaciones, delirios.
Trastorno bipolar	Afectividad episódica, no reactividad inmediata.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

En APS, **no se requieren exámenes específicos** para diagnosticar un TP.

Sin embargo, el médico debe descartar causas médicas o farmacológicas que expliquen los síntomas (por ejemplo, hipotiroidismo, consumo de sustancias o fármacos con efecto neuropsiquiátrico).

Criterios orientadores (DSM-5)

- Patrón persistente e inflexible que afecta al menos dos áreas: cognición, afectividad, relaciones o control de impulsos.
- Inicio precoz, estable y prolongado.
- Deterioro significativo en el funcionamiento.
- No atribuible a otra enfermedad o sustancia.

Herramientas disponibles

- **Entrevista clínica estructurada.**
 - **Observación longitudinal del comportamiento.**
 - **Interconsulta psicológica** para evaluación de personalidad (COSAM o psicología APS).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Enfoque general

El manejo en APS no pretende “curar” el TP, sino **contener, orientar y coordinar la atención.**

Los pilares del tratamiento son:

1. **Psicoeducación.**
 2. **Manejo comunicacional.**
 3. **Establecimiento de límites claros.**
 4. **Derivación a salud mental según criterios definidos.**
-

5.2. Psicoeducación

- Explicar que la personalidad tiene componentes biológicos y ambientales.
- Normalizar la búsqueda de ayuda psicológica.

- Reforzar que el cambio requiere **tiempo y constancia**.
- Educar a la familia o red de apoyo sobre cómo **establecer límites y evitar sobreprotección**.

□ Ejemplo de intervención:

“Comprendo que le cuesta manejar sus emociones. Hay terapias especializadas que pueden ayudarle a entender sus reacciones y aprender nuevas formas de relacionarse.”

5.3. Manejo comunicacional en consulta

El vínculo terapéutico es la herramienta central.

Se recomienda aplicar la estrategia de las “**tres C**”:

1. **Consistencia:** mantener una actitud calmada y predecible.
2. **Claridad:** definir objetivos concretos y límites conductuales.
3. **Contención:** validar emociones sin reforzar conductas disfuncionales.

□ **Consejos prácticos:**

- Evitar enfrentamientos o juicios morales.
- No discutir “quién tiene la razón”.
- Fijar tiempos de atención y respetarlos.
- Documentar incidentes o amenazas para respaldo del equipo.

□ Pacientes con TP pueden generar desgaste emocional en el equipo. Es fundamental la **supervisión y apoyo institucional**.

5.4. Intervenciones no farmacológicas

- **Terapia Cognitivo-Conductual (TCC):** modificar patrones de pensamiento rígidos.
- **Terapia Dialéctico-Conductual (TDC):** especialmente en TLP (regulación emocional).

- **Terapia de apoyo y psicoeducación familiar.**
 - **Talleres psicosociales (COSAM):** habilidades sociales, manejo de impulsos.
-

5.5. Tratamiento farmacológico (coadyuvante)

En APS, el uso de fármacos se reserva para **síntomas comórbidos**, no para la personalidad en sí.

Síntoma / problema	Fármaco sugerido	Precauciones
Ansiedad o irritabilidad	ISRS (sertralina, escitalopram)	Evitar benzodiazepinas prolongadas.
Impulsividad o agresividad	Valproato, lamotrigina	Control de niveles séricos.
Inestabilidad afectiva / disociación	Quetiapina, olanzapina	Vigilar efectos metabólicos.
Insomnio	Trazodona o mirtazapina (en vez de BDZ)	Evitar dependencia.

☐ El MINSAL enfatiza que el tratamiento debe ser **integral y centrado en la persona**, con acompañamiento psicosocial más que farmacológico exclusivo.

5.6. Derivación a segundo nivel (COSAM / Psiquiatría)

Criterios de derivación:

1. Riesgo suicida o autolesiones repetidas.
2. Conductas agresivas o violentas hacia terceros.
3. Fallo del manejo ambulatorio en APS.

4. Comorbilidad grave (depresión mayor, consumo de sustancias, psicosis).
5. Deterioro funcional significativo (pérdida laboral, abandono familiar).

Vía de derivación:

- **Derivación preferente (urgente):** riesgo vital, autolesión, ideación suicida activa.
- **Derivación prioritaria:** deterioro social/laboral severo, crisis conductual grave.
- **Derivación programada:** sospecha de TP sin riesgo inmediato.

□ En Chile, el nivel secundario corresponde al **COSAM (Centro Comunitario de Salud Mental)** o **Hospital de Día Psiquiátrico**, donde existen equipos multidisciplinarios especializados.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones frecuentes

- **Riesgo suicida o parasuicida (TLP).**
- **Adherencia terapéutica baja.**
- **Conductas impulsivas o antisociales.**
- **Desgaste del equipo tratante.**
- **Conflictos familiares crónicos.**

6.2. Pronóstico

Depende de:

- **Tipo de TP:** el TLP puede mejorar notablemente con tratamiento; el antisocial es el de peor pronóstico.
- **Nivel de apoyo social.**
- **Motivación y adherencia.**
- **Acceso a psicoterapia prolongada.**

- En promedio, entre 40–60% de los pacientes muestran mejoría funcional significativa a 10 años.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas clínicas

1. El rol del médico en APS es **contener y derivar**, no diagnosticar formalmente.
 2. **Límites claros y consistencia** son esenciales en la relación terapéutica.
 3. La **TDC** es la terapia más efectiva en TLP; la **TCC**, en TP evitativo y obsesivo.
 4. Evitar **benzodiacepinas prolongadas** por riesgo de abuso.
 5. Los TP son **egosintónicos**: el paciente no percibe su conducta como problema.
 6. Incluir siempre a la **familia o red de apoyo** en el plan terapéutico.
 7. Registrar y comunicar **conductas de riesgo o amenazas** de manera institucional.
-

□

Errores comunes

- Etiquetar rápidamente al paciente como “manipulador” o “conflictivo”.
 - Indicar psicofármacos sin apoyo psicoterapéutico.
 - Intentar “curar” un TP en APS.
 - No establecer límites claros (por ejemplo, consultas fuera de horario).
 - No derivar oportunamente ante riesgo suicida.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **manejo en APS** se centra en **contención emocional, psicoeducación y derivación**.
2. El diagnóstico formal debe realizarlo un **equipo especializado (COSAM / psiquiatría)**.
3. La **relación terapéutica** requiere **consistencia, claridad y empatía sin sobreinvolucrarse**.
4. Los **fármacos son coadyuvantes**, enfocados en síntomas comórbidos (ansiedad, depresión, impulsividad).
5. La **derivación urgente** se indica ante riesgo suicida, violencia o fracaso del manejo ambulatorio.
6. El pronóstico mejora con **redes de apoyo sólidas** y psicoterapia prolongada.
7. En EUNACOM, los ítems suelen evaluar la **comunicación clínica y el juicio profesional**, no el uso de medicamentos.